

CONSENTIMIENTO INFORMADO

VIDEOTORACOSCOPIA (VATS) DIAGNÓSTICA Y/O TERAPÉUTICA

Biopsia pleural / VATS exploradora / Decorticación pulmonar / Pleurodesis (sellado pleural)

Apellido y Nombre	[Apellido y Nombre del paciente]		
DNI	[DNI]	Fecha de nacimiento	[_/_/_]
Edad	[Edad]	Sexo	[Sexo]
Domicilio	[Domicilio completo]		
Obra Social	[Obra Social]	Nº de afiliado	[Nº Afiliado]
Institución / Sanatorio	[Nombre del Sanatorio]	Fecha del acto	[_/_/_]
Médico interviniente	Dr. Pablo Maynard — Cirujano Torácico UBA — M.N. 121828 / M.P. 232938		

Procedimiento propuesto (marcar el/los que correspondan):

- ☐ VATS exploradora / diagnóstica
- ☐ Biopsia pleural
- ☐ Decorticación pulmonar (por empiema/paquipleuritis)
- ☐ Pleurodesis mecánica y/o química (sellado pleural)

1. DIAGNÓSTICO

[Completar diagnóstico específico del paciente — ej.: derrame pleural a estudio / empiema pleural en organización / neumotórax recidivante / derrame pleural maligno, etc.]

2. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO

Bajo anestesia general y ventilación unipulmonar, se accede a la cavidad pleural a través de pequeños orificios en el tórax (videotoracosopia). Según el hallazgo intraoperatorio y el objetivo del procedimiento, se explora la cavidad pleural, se toman biopsias de pleura y/o de nódulos sospechosos, se evacúan colecciones tabicadas, se libera la corteza fibrosa que restringe la expansión del pulmón (decorticación) y/o se realiza abrasión mecánica y/o instilación de un agente esclerosante (talco u otro) para lograr la adhesión de las hojas pleurales (pleurodesis). Al finalizar se deja colocado uno o más tubos de drenaje pleural.

3. OBJETIVO Y BENEFICIOS ESPERADOS

Obtener diagnóstico etiológico del derrame o engrosamiento pleural; lograr la reexpansión del pulmón atrapado; controlar un foco infeccioso pleural (empiema); y/o controlar la recidiva de un derrame pleural (maligno o de otra causa) o de un neumotórax mediante pleurodesis.

4. RIESGOS Y COMPLICACIONES POSIBLES

4.1 Riesgos generales de la anestesia y de la cirugía torácica

- Reacciones a la anestesia general, complicaciones cardiovasculares o respiratorias.
- Sangrado intraoperatorio y/o postoperatorio, con eventual necesidad de transfusión.

- Infección de la herida quirúrgica.
- Neumonía y/o atelectasia postoperatoria.
- Arritmias cardíacas postoperatorias.
- Trombosis venosa profunda y/o tromboembolismo pulmonar.
- Necesidad de reoperación.
- Dolor postoperatorio persistente.
- Muerte, como riesgo infrecuente pero posible de todo procedimiento quirúrgico mayor bajo anestesia general.

4.2 Riesgos específicos

- Sangrado por decorticación de superficies inflamadas o friables, en ocasiones con requerimiento transfusional.
- Fuga aérea prolongada por lesión de la superficie pulmonar durante la decorticación, frecuente en pulmones con paquipleuritis crónica.
- Edema pulmonar de reexpansión, tras el drenaje rápido de derrames voluminosos o neumotórax de larga evolución, que en casos graves puede requerir asistencia respiratoria mecánica.
- Reexpansión pulmonar incompleta, con persistencia de un espacio pleural residual.
- Persistencia o recidiva de la infección pleural (empiema), con necesidad de drenajes adicionales, decorticación abierta por toracotomía o, en casos extremos, toracostomía abierta (ventana pleural).
- Recidiva del derrame pleural maligno a pesar de la pleurodesis (tasa de fracaso variable según las series, en torno al 10-20%).
- Dolor pleurítico agudo durante y después de la instilación del agente esclerosante, en particular con talco.
- Distrés respiratorio agudo post-pleurodesis con talco: complicación infrecuente pero descrita en la bibliografía.
- Conversión a toracotomía abierta si el procedimiento no puede completarse en forma segura por vía toracoscópica (adherencias extensas, sangrado no controlable por VATS).
- Necesidad de mantener el tubo de drenaje pleural por tiempo prolongado.
- Resultado no diagnóstico en los procedimientos exploratorios/de biopsia, requiriendo un estudio adicional.

5. ALTERNATIVAS TERAPÉUTICAS

Toracocentesis evacuadora simple; colocación de catéter pleural tunelizado permanente (especialmente en derrame pleural maligno recidivante); pleurodesis química a través de tubo de drenaje sin cirugía; tratamiento antibiótico prolongado sin drenaje quirúrgico en empiema de fase temprana; conducta expectante según el cuadro clínico.

6. CONSECUENCIAS DE NO REALIZAR EL PROCEDIMIENTO

Persistencia del derrame, del atrapamiento pulmonar y/o de la infección pleural, con deterioro respiratorio progresivo y riesgo de sepsis de origen pleural; posible evolución a fibrotórax con pérdida permanente de función pulmonar; en el contexto oncológico, ausencia de diagnóstico o de control paliativo del derrame.

7. DECLARACIÓN DEL PACIENTE

Declaro que el Dr. Pablo Maynard y su equipo me han explicado, en lenguaje claro y comprensible, mi diagnóstico, el procedimiento propuesto, sus beneficios esperados, los riesgos y complicaciones posibles —generales y específicos—, las alternativas terapéuticas disponibles y las consecuencias previsibles de no realizar el procedimiento. He tenido la oportunidad de formular todas las preguntas que consideré necesarias y las mismas fueron respondidas de manera satisfactoria. Comprendo que la Medicina no es una ciencia exacta y que no se me ha garantizado un resultado determinado. En consecuencia, presto mi consentimiento libre, voluntario e informado para la realización del procedimiento descrito en el presente documento, incluyendo los procedimientos anestésicos necesarios para su realización.

8. AUTORIZACIONES ADICIONALES

- ☐ Autorizo la ampliación o modificación del procedimiento planificado si, durante el acto operatorio, surgieran hallazgos imprevistos que a criterio del equipo actuante hagan necesario o conveniente dicho cambio para preservar mi salud o mi vida.
- ☐ Autorizo la administración de hemoderivados (transfusión) en caso de ser necesario.

- ☐ Autorizo el envío de las muestras/tejidos obtenidos a estudio anatomopatológico y, de corresponder, a estudios moleculares/genéticos complementarios.
- ☐ Autorizo la toma de fotografías/videos del procedimiento con fines académicos y/o de docencia, resguardando mi identidad (Art. 8º, Ley 26.529). En caso de no autorizar, tildar la opción correspondiente:
- ☐ No autorizo la toma de fotografías/videos con fines académicos.

9. REVOCABILIDAD DEL CONSENTIMIENTO

Entiendo que este consentimiento puede ser revocado por mí en cualquier momento previo a la realización del procedimiento, sin necesidad de expresar causa y sin que ello genere consecuencia negativa alguna sobre mi atención médica posterior (Art. 10, Ley 26.529).

10. FIRMAS

Firma: _____ PACIENTE — Nombre: _____ DNI: _____	
Firma: _____ REPRESENTANTE LEGAL (si corresponde) — Nombre: _____ DNI: _____ Vínculo: _____	
Firma y sello: _____ MÉDICO INTERVINIENTE	Firma: _____ TESTIGO (opcional) — Nombre: _____ DNI: _____